

Cognome LOFINO
Data di Nascita: 29/12/1995
Sesso: Maschio
Comune di residenza: ROMA (RM)

Nome: SAMUELE
Luogo di nascita: ROMA
Codice fiscale: LFNSML95T29H501D
Indirizzo di residenza: VIA DEL TAVOLATO N, 32 SC, ROMA 00178 RM
Telefono: 3913561301 0671280067
Email:
BARCODE Paziente:

BARCODE Episodio:



01A251790860



28558070



UTK23158747

UO Accettante: DIREZIONE SANITARIA - Unità Operativa di CDP_CARDIOLOGIA
UO Erogante: SERVIZIO CARDIOLOGIA - TRADIZIONALE
Verbale n.: 01A251790860
Episodio Ambulatoriale

Esami eseguiti:

89.01.3 VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO (89.01.3_2) - 18/12/2025 14:12

Referto / Descrizione clinica

Età: 29 anni Peso: 73 kg Altezza: 185 cm

Motivo della visita: displasia polmonare con steno-insufficienza di grado lieve.

Allergie: Graminacee. Nega per farmaci, alimenti e mdc.

Fattori di rischio cardiovascolare: nega

Comorbidità: IC frattura scafoide mano sinistra, IC per strabismo, IC per varicocele

Visita di controllo in paziente con diagnosi alla nascita di steno-insufficienza polmonare in valvolare displasica (bicuspidale).

Storia cardiologica:

Diagnosi alla nascita di steno-insufficienza polmonare di grado lieve in valvola displasica, per cui ha eseguito regolari controlli cardiologici negli anni (OPBG, Policlinico Umberto I, Campus Bio-medico, Policlinico Casilino). Nel 2020 eseguiva controllo cardiologico presso il Campus Bio-medico e all'ecocardiogramma si riscontrava: displasia valvolare polmonare con lieve stenosi (Gmax/med 19/13 mmHg), dilatazione del tronco polmonare (42 mm) in aumento rispetto al controllo dell'anno precedente (2019). Eseguita, pertanto, RM cuore presso il Policlinico Casilino (2020) che documentava: Valvola polmonare bicuspidale (rafe tra cuspidi anteriore e cuspidi sinistra) con steno-insufficienza di grado lieve (Vmax 2 m/s) e dilatazione del tronco dell'arteria polmonare (44 mm, rapporto Ap/Ao 1.7), arteria polmonare destra 18 mm, arteria polmonare sinistra 26 mm, ventricolo destro di dimensioni ai limiti superiori della norma (Vdx/Vsx 1.08) con normale funzione contrattile, ventricolo sinistro di normali spessori e dimensioni, normofunzionante, non ulteriori valvulopatie di rilievo. All' ECG Holter (Aprile 2021): Ritmo sinusale (FC media 81 bpm, FC max 167 bpm, FC min 41 bpm). Normale conduzione AV e IV. 4 BEV monomorfi. 1 BESV, 1 run. Non pause significative. Non sintomi. Ultimo ECG da sforzo (Luglio 2022): Normale comportamento cronotropo e del profilo pressorio, non sintomi, inversione delle onde T in sede infero-laterale (già nota ad altri tds). Veniva, pertanto, posta indicazione a esecuzione di Angio-TC coronarica (Agosto 2022): Circolo a dominanza destra. Accenno di tronco comune per origine disgiunta di Cx e DA dal seno coronarico di sinistra. Normale calibro e decorso della DA e della Cx. Mal valutabile la CDx, normo-rappresentazione dei rami postero-laterale e IVP, non valutabili. Tronco AP: 41 mm, APSx 30x28 mm, APDx 24x22 mm, Aorta ascendente 30 mm.

Prima visita presso questo ambulatorio a gennaio 2023 il paziente si presentava in buone condizioni generali, negava sintomatologia di natura cardiaca. L' ecocardiogramma confermava la presenza di una lieve steno-insufficienza valvolare polmonare e dimensioni del tronco polmonare di 40-41 mm.

Dall'ultima visita, riferito benessere clinico, in assenza di angor, dispnea e/o cardiopalmo. Nega sincope.

Reca in visione:

-RM CUORE (14/02/2025): FE VS 55%, FE VD 55%, volumi biventricolari nei limiti. Non alterazioni della cinetica segmentaria e regionale. No edema miocardico. Valvola polmonare bicuspidale con IP lieve. Non aree di LGE. Non riportati i valori del tronco polmonare e dei suoi rami. Calcolate le misure dalle acquisizioni disponibili su dischetto: in telesistole tronco polmonare max 43 mm, APsx max 28-29 mm, APdx 26 mm.

-EE (23/01/2025): Hb 14.6 g/dl, WBC 5mila/mcl, PLT 295k/mcl, creat 0.90 mg/dl

Terapia domiciliare: nessuna ad eccezione di anti-istaminici del periodo primaverile.

Alla visita odierna paziente in buone condizioni generali.

Pratica regolarmente attività fisica non agonistica (nuoto, ciclismo, corsa) senza limitazioni. Nega dispnea, angore, cardiopalmo.

Riferisce sporadici episodi lipotimici situazionali (dolore intenso, digiuno prolungato). Buon controllo domiciliare della pressione arteriosa, nei limiti della norma la FC circadiana al monitoraggio mediante smart-watch.

PA: 120/50 mmHg (sa di avere ipertensione da camice bianco)

FC: 95 bpm

EOC: attività cardiaca ritmica, toni netti, SS 2-3/6 su focolaio polmonare

EOT: Emitoraci simmetrici, normoespansibili, MV normale bilateralmente

EG: ritmo sinusale (FC 93 bpm), ritardo aspecifico di conduzione IV.

Si consiglia

Conclusioni: Paziente con diagnosi alla nascita di displasia della valvola polmonare con associata lieve steno-insufficienza. Ha eseguito regolare follow-up presso diverse strutture con sostanziale stabilità del quadro clinico strumentale fino al 2020, quando, in considerazione del riscontro di aumento del diametro dell'arteria polmonare rispetto al 2019 (42 vs 34 mm ma il paziente riferisce che gli esami sono stati fatti da medici diversi e con macchine diverse), è stato sottoposto ad angioRM e angioTC, che hanno confermato il valore di 42 mm circa di tronco polmonare, stabile dal 2020. Ultima RM cuore del 2025 (Policlinico Casilino) in cui non vengono riportate le misure dell'arteria polmonare e dei suoi rami, risultate stabili rispetto ai precedenti calcolate dalle immagini del dischetto in visione. Veniva indicata prosecuzione del follow-up presso il centro di riferimento (Policlinico Casilino), dove tuttavia gli consigliavano prosecuzione del follow up presso il nostro ambulatorio. Alla visita odierna il paziente si presenta in buone condizioni generali, nega sintomatologia di natura cardiaca. Il nostro ecocardiogramma conferma la presenza di una lieve steno-insufficienza valvolare polmonare e dimensioni del tronco polmonare di max 42 mm pre-biforcazione. Si consiglia di ripetere RM cuore per monitoraggio dei rami arteriosi polmonari ogni due anni. Prossima valutazione presso il nostro centro programmata per il 15/06/2028 ore 8:15.

IL MEDICO

GIULIA IANNACCONE



Dipartimento di Medicina Cardiovascolare
UOSA Diagnostica Cardiologica non invasiva
Laboratorio di Ecocardiografia

Paziente:	LOFINO SAMUELE	CS Paziente:	28558070
Età:	29	Data di Nascita:	29/12/1995
Data Esame:	18/12/2025		
Provenienza:	CDP_CARDIOLOGIA		

ECOCARDIOGRAMMA COLOR DOPPLER

Ritmo Cardiaco: Sinusale
Peso (kg): 73 Altezza (cm): 185 BSA: 1.96

Commenti

vedi conclusioni

Conclusioni

Steno-insufficienza valvolare polmonare lieve (Gmax 18 mmHg, PHT 264 ms).
Dilatazione MPA con diametro massimo 42 mm prima della biforcazione.
Ventricolo destro di dimensioni nei limiti della norma, con conservata funzione contrattile (TAPSE 24 mm, S'TDI 15 cm/s, RV-FAC 53%). PAPs tecnicamente non campionabile, non segni indiretti di ipertensione polmonare.
Atrio destro di dimensioni nei limiti.
Minima insufficienza tricuspide.
VCI dilatata (22 mm), ma normocollassante con l'inspiratione.
Non versamento pericardico.

Ventricolo sinistro di normali spessori, dimensioni endocavitarie (EDV 114 ml, EDVi 59 ml/m²) e normale funzione contrattile globale (AutoEF 57%, GLS GE Vivid -17%, LVOT VTI 16 cm) e regionale.
Atrio sinistro di normali dimensioni endocavitarie.
Funzione diastolica nei limiti (E/A 1, E/E' medio 4).
Lieve insufficienza mitralica.
Valvola aortica di morfologia tricuspide con conservato movimento di apertura (Gmax 5 mmHg) e trascurabile rigurgito.
Bulbo aortico (31 mm), aorta ascendente (30 mm) ed arco aortico (26 mm) di calibro nei limiti della norma nei tratti esplorabili.

Medico Dr. Di Perna Federico
Medico Dr. Scarica Vincenzo

Medico Refertatore Dr.ssa Iannaccone Giulia

Data Referto: 18/12/2025 14:20

Cognome LOFINO
Data di Nascita: 29/12/1995
Sesso: Maschio
Comune di residenza: ROMA (RM)

Nome: SAMUELE
Luogo di nascita: ROMA
Codice fiscale: LFNSML95T29H501D
Indirizzo di residenza: VIA DEL TAVOLATO N, 32 SC, ROMA 00178 RM
Telefono: 3913561301 0671280067
Email:
BARCODE Paziente:

BARCODE Episodio:



01A250924271



28558070

UO Accettante: DIREZIONE SANITARIA - Unità Operativa di RECUP
UO Erogante: AMBUL CARDIOCHIRURGIA (8D)
Verbale n. 01A250924271
Episodio Ambulatoriale



UITK00030693

Esami eseguiti:

VISITA CARDIOCHIRURGICA (89.7_102) VISITA CARDIOCHIRURGICA (89.7_102) - 02/07/2025 10:46

Referto / Descrizione clinica

Età: 29 anni

Peso: 78 kg Altezza: 185 cm

Motivo della visita: displasia polmonare con steno-insufficienza di grado lieve.

Allergie: Graminacee. Nega per farmaci, alimenti e mdc.

Fattori di rischio cardiovascolare: nega

Comorbidità: IC frattura scafoide mano sinistra, IC per strabismo, IC per varicocele

Storia cardiologica Diagnosi alla nascita di steno-insufficienza polmonare di grado lieve in valvola displasica, per cui ha eseguito regolari controlli cardiologici negli anni (OPBG, Policlinico Umberto I, Campus Bio-medico, Policlinico Casilino). Nel 2020 eseguiva controllo cardiologico presso il Campus Bio-medico e all'ecocardiogramma si riscontrava: displasia valvolare polmonare con lieve stenosi (Gmax/med 19/13 mmHg), dilatazione del tronco polmonare (42 mm) in aumento rispetto al controllo dell'anno precedente (2019). Eseguita, pertanto, RM cuore presso il Policlinico Casilino (2020) che documentava: Valvola polmonare bicuspid (rafe tra cuspid anteriore e cuspid sinistra) con steno-insufficienza di grado lieve (Vmax 2 m/s) e dilatazione del tronco dell'arteria polmonare (44 mm, rapporto Ap/Ao 1.7), arteria polmonare destra 18 mm, arteria polmonare sinistra 26 mm, ventricolo destro di dimensioni ai limiti superiori della norma (Vdx/Vsx 1.08) con normale funzione contrattile, ventricolo sinistro di normali spessori e dimensioni, normofunzionante, non ulteriori valvulopatie di rilievo.

-Eseguita Angio-TC coronarica (Agosto 2022): Circolo a dominanza destra. Accenno di tronco comune per origine disgiunta di Cx e DA dal seno coronarico di sinistra. Normale calibro e decorso della DA e della Cx. Mal valutabile la CDx, normo-rappresentazione dei rami postero-laterale e IVP, non valutabili. Tronco AP: 41 mm, APSx 30x28 mm, APDx 24x22 mm, Aorta ascendente 30 mm.

Reca in visione:

-RM CUORE (14/02/2025): FEVS 55%, non HVS, né dilatazione del VS. FEVD 55%, non HVD, né dilatazione del VD. Non aree di LGE di significato patologico.

Terapia domiciliare: nega

Alla visita odierna paziente in buone condizioni generali.

Pratica regolarmente attività fisica non agonistica (nuoto, ciclismo, corsa) senza limitazioni. Nega dispnea, angore, cardiopalmo.

Attività cardiaca ritmica, toni netti, SS 3/6 su focolaio polmonare.

Torace normoconformato. Emitoraci simmetrici, normoespansibili, MV normotrasmeso bilateralmente. Non edemi declivi.

All'ECG: Ritmo sinusale a FC 78 bpm



Paziente:	LOFINO SAMUELE	CS Paziente:	28558070
Età:	27	Data di Nascita:	29/12/1995
Data Esame:	12/01/2023		
Provenienza:	AMBULATORIO GUCH		

ECOCARDIOGRAMMA COLOR DOPPLER

Motivo dell'Esame: STENOSI

Ritmo Cardiaco: Sinusale

Peso (kg): 78

Altezza (cm): 185

BSA: 2.01

Commenti

vedi conclusioni

Conclusioni

Steno-insufficienza valvolare polmonare lieve (Gmax 18 mmHg).

Dilatazione MPA con diametro massimo 40-42 mm prima della biforcazione, rami polmonari 15 e 21 mm.

Ventricolo destro di dimensioni nei limiti della norma (diametro basale 31 mm, LL/2 23 mm), con normale cinesi (TAPSE 21 mm). PAPs tecnicamente non campionabile, non segni indiretti di ipertensione polmonare.

Atrio destro di dimensioni nei limiti.

Minima insufficienza tricuspide.

VCI di regolare calibro e collasso inspiratorio.

Non versamento pericardico.

Ventricolo sinistro di normali spessori, dimensioni endocavitarie e normale funzione contrattile globale e regionale.

Atrio sinistro di normale volume.

Funzione diastolica nei limiti (E/E' medio 4).

Normale la valvola mitralica.

Valvola aortica di morfologia tricuspide con trascurabile rigurgito.

Bulbo aortico, aorta ascendente ed arco aortico di calibro nei limiti della norma nei tratti esplorabili.

Specializzando Dr. Cribari Francesco

Medico Refertatore Dr.ssa Graziani Francesca

**Dipartimento di Medicina Cardiovascolare
UOSA Diagnostica Cardiologica non invasiva
Laboratorio di Ecocardiografia**

Ventricolo sinistro

Frazione di Eiezione Teichholz	59	%	B-Mode	[52 - 72]
Frazione di Eiezione Teichholz	64	%	M-Mode	[52 - 72]
Diametro TeleDiastolico	47	mm	B-Mode	[37 - 52]
Diametro TeleDiastolico	38,5	mm	M-Mode	[37 - 52]
Diametro TeleSistolico	32,2	mm	B-Mode	[25 - 40]
Diametro TeleSistolico	25,3	mm	M-Mode	[25 - 40]
Setto Interventricolare: Spessore TD	* 12,4	mm	M-Mode	[max: 11]
Parete Posteriore: Spessore TD	8,4	mm	B-Mode	[6 - 10]
Parete Posteriore: Spessore TD	9,8	mm	M-Mode	[6 - 10]
Setto Interventricolare: Spessore TD	10,3	mm	B-Mode	[max: 11]
Massa/BSA Cube Method	69,2	g/m ²	M-Mode	[49 - 115]
Massa/BSA	74,9	g/m ²	B-Mode	[49 - 115]
Massa/Altezza	81,41	g/m	B-Mode	[52 - 126]
Massa/Altezza	75,14	g/m	M-Mode	[52 - 126]
Volume TeleSistolico Teichholz	42	ml	B-Mode	[21 - 61]
Volume TeleDiastolico Teichholz	102	ml	B-Mode	[62 - 150]
Volume TeleDiastolico Teichholz	64	ml	M-Mode	[62 - 150]
Volume TeleDiastolico Ind. Teichholz	* 32	ml/m ²	M-Mode	[35 - 75]
Volume TeleDiastolico Ind. Teichholz	51	ml/m ²	B-Mode	[35 - 75]
Volume TeleSistolico Ind. Teichholz	21	ml/m ²	B-Mode	[11 - 31]
Stroke Volume Index Teichholz	30	ml/m ²	B-Mode	
Accorciamento frazionale Teichholz	34	%	M-Mode	[25 - 43]
Accorciamento frazionale Teichholz	32	%	B-Mode	[25 - 43]
Parete Posteriore: Spessore TS	15,9	mm	M-Mode	
Relative Wall Thickness	0,4		B-Mode	[0,24 - 0,42]
Setto Interventricolare: Rapporto SIV/PP	1,22		B-Mode	
Stroke Volume Teichholz	60	ml	B-Mode	
Stroke Volume Teichholz	40,9	ml	M-Mode	

Funzione Diastolica

Velocità Picco Onda E	0,6	m/s	Doppler	
Rapporto E/A	1		Doppler	
Rapporto E/E'	6,5		Doppler	
Decelerazione E	177	ms	Doppler	
Velocità Picco Onda A	0,62	m/s	Doppler	

Aorta

Diametro Bulbo	33	mm	M-Mode	[21 - 35]
Diametro Aorta Ascendente	29,8	mm	B-Mode	[17 - 34]

Valvola mitrale

Nome Paziente: LOFINO SAMUELE
Data di Nascita: ROMA, 29/12/1995
Indirizzo: VIA DEL TAVOLATO N, 32 SC, 00178 ROMA
Telefono: 06 71280067 392 0312016

ID Paziente: 28558070
Codice Fiscale: LFNSML95T29H501D
ASL: ROMA 2
e-mail:

UO Accettante: AMBUL GUCH
UO Erogante: AMBUL GUCH
Verbale n. 01A221329355
Episodio Ambulatoriale



Esami eseguiti:

89.7 - VISITA CARDIOLOGICA (89.7_7) - 12/01/2023 13:54

Referto / Descrizione clinica

Età: 27 anni

Peso: 78 kg Altezza: 185 cm

Motivo della visita: displasia polmonare con steno-insufficienza di grado lieve.

Allergie: Graminacee. Nega per farmaci, alimenti e mdc.

Fattori di rischio cardiovascolare: nega

Comorbidità: IC frattura scafoide mano sinistra, IC per strabismo, IC per varicocele

Prima visita in paziente con diagnosi alla nascita di steno-insufficienza polmonare in valvolare displasica (bicuspid)

Storia cardiologica

Diagnosi alla nascita di steno-insufficienza polmonare di grado lieve in valvola displasica, per cui ha eseguito regolari controlli cardiologici negli anni (OPBG, Policlinico Umberto I, Campus Bio-medico, Policlinico Casilino).

Nel 2020 eseguiva controllo cardiologico presso il Campus Bio-medico e all'ecocardiogramma si riscontrava: displasia valvolare polmonare con lieve stenosi (Gmax/med 19/13 mmHg), dilatazione del tronco polmonare (42 mm) in aumento rispetto al controllo dell'anno precedente (2019).

Eseguiva, pertanto, RM cuore presso il Policlinico Casilino (2020) che documentava: Valvola polmonare bicuspid (refe tra cuspid anteriore e cuspid sinistra) con steno-insufficienza di grado lieve (Vmax 2 m/s) e dilatazione del tronco dell'arteria polmonare (44 mm, rapporto Ap/Ao 1.7), arteria polmonare destra 18 mm, arteria polmonare sinistra 26 mm, ventricolo destro di dimensioni ai limiti superiori della norma (Vdx/Vsx 1.08) con normale funzione contrattile, ventricolo sinistro di normali spessori e dimensioni, normofunzionante, non ulteriori valvulopatie di rilievo.

In visione ECG Holter (Aprile 2021): Ritmo sinusale (FC media 81 bpm, FC max 167 bpm, FC min 41 bpm). Normale conduzione AV e IV. 4 BEV monomorfi. 1 BESV, 1 run. Non pause significative. Non sintomi.

Ultimo ECG da sforzo (Luglio 2022): Normale comportamento cronotropo e del profilo pressorio, non sintomi, inversione delle onde T in sede infero-laterale (già nota ad altri tds).

Veniva, pertanto, posta indicazione a esecuzione di Angio-TC coronarica (Agosto 2022): Circolo a dominanza destra.

Accenno di tronco comune per origine disgiunta di Cx e DA dal seno coronarico di sinistra. Normale calibro e decorso della DA e della Cx. Mal valutabile la CDx, normo-rappresentazione dei rami postero-laterale e IVP, non valutabili. Tronco AP: 41 mm, APSx 30x28 mm, APDx 24x22 mm, Aorta ascendente 30 mm.

Terapia domiciliare: nessuna ad eccezione di anti-istaminici del periodo primaverile.

Nome Paziente: LOFINO SAMUELE

ID Paziente: 28558070

Data di Nascita: ROMA, 29/12/1995

Codice Fiscale: LFNSML95T29H501D

Indirizzo: VIA DEL TAVOLATO N, 32 SC, 00178 ROMA

ASL: ROMA 2

Telefono: 06 71280067 392 0312016

e-mail:

UO Accettante: AMBUL GUCH

UO Erogante: AMBUL GUCH

Verbale n. 01A221329355

Episodio Ambulatoriale



Alla visita odierna paziente in buone condizioni generali. Pratica regolarmente attività fisica non agonistica (nuoto, ciclismo, corsa) senza limitazioni. Nega dispnea, angor, cardiopalmo. Riferisce sporadici episodi lipotimici situazionali (dolore intenso, digiuno prolungato). Buon controllo domiciliare della pressione arteriosa, nei limiti della norma la FC circadiana al monitoraggio mediante smart-watch.

PA: 150/80 mmHg (sa di avere ipertensione da camice bianco) FC: 104 bpm

EOC: attività cardiaca ritmica, toni netti, SS 2-3/6 su focolaio polmonare

EOT: Emitoraci simmetrici, normoespansibili, MV normale bilateralmente

Si consiglia

Conclusioni

Paziente con diagnosi alla nascita di displasia della valvola polmonare con associata lieve steno-insufficienza. Ha eseguito regolare follow-up presso diverse strutture con sostanziale stabilità del quadro clinico strumentale fino al 2020, quando, in considerazione del riscontro di aumento del diametro dell'arteria polmonare rispetto al 2019 (42 vs 34 mm ma il paziente riferisce che gli esami sono stati fatti da medici diversi e con macchine diverse), è stato sottoposto ad angioRM e angioTC, che hanno confermato il valore di 42 mm circa di tronco polmonare, stabile dal 2020.

Alla visita odierna il paziente si presenta in buone condizioni generali, nega sintomatologia di natura cardiaca. Il nostro ecocardiogramma conferma la presenza di una lieve steno-insufficienza valvolare polmonare e dimensioni del tronco polmonare di 40-41 mm. Il paziente continuerà il fup presso il Policlinico Casilino dopo il nostro videat CCH vedi referto).

IL MEDICO
FRANCESCA GRAZIANI

Nome Paziente: LOFINO SAMUELE
Data di Nascita: ROMA, 29/12/1995
Indirizzo: VIA DEL TAVOLATO N, 32 SC, 00178 ROMA
Telefono: 06 71280067 392 0312016

ID Paziente: 28558070
Codice Fiscale: LFNSML95T29H501D
ASL: ROMA 2
e-mail:

UO Accettante: AMBUL GUCH
UO Erogante: AMBUL GUCH
Verbale n. 01A221329355
Episodio Ambulatoriale



Esami eseguiti:

89.7 - VISITA CARDIOCHIRURGICA (89.7_6) - 12/01/2023 14:23

Referto / Descrizione clinica

Paziente di 27 anni con diagnosi alla nascita di displasia della valvola polmonare con associata lieve steno-insufficienza. Regolare follow-up presso diverse strutture con sostanziale stabilità del quadro clinico strumentale fino al 2020, quando, in considerazione del riscontro di aumento del diametro dell'arteria polmonare rispetto al 2019 (42 vs 34 mm ma il paziente riferisce che gli esami sono stati fatti da medici diversi e con macchine diverse), è stato sottoposto ad angioRM e angioTC, che hanno confermato il valore di 42 mm circa di tronco polmonare, stabile dal 2020.

Porta in visione angio-TC cardiosincronizzata che mostra regolare accenno di TC e origine disgiunta della DA e Cx con normale calibro e decorso. Mal valutabile il decorso della coronaria destra, con normale origine dall'ostio di destra: non reperti patologici coronarici.

Ottime condizioni generali, nega sintomatologia, pratica sport regolarmente (nuoto, ciclismo)

Al'ecocardiogramma eseguito in data odierna si conferma la presenza di una lieve steno-insufficienza valvolare polmonare e dilatazione del tronco polmonare (40-41 mm).

Al momento non sussiste indicazione ad intervento cardiocirurgico.

Si consiglia regolare follow-up cardiologico con ecocardiogramma presso il proprio centro di riferimento (Policlinico Casilino) ed esecuzione di angioTC oppure RMN cardiaca di controllo ogni 2 anni. Seguire le indicazioni presenti nella visita cardiologica allegata.

Si resta a completa disposizione per eventuali chiarimenti o variazione del quadro clinico.

IL MEDICO
MARIA GRANDINETTI